

PÉDIATRIE — MALADIES DE L'ENFANT

Fiches QE Haute Fréquence (FMPM) — Version 1

Cross-match : 700 QEs officielles (2017→2026) × Cours AIO (pédiatrie + néonatalogie + chirurgie pédiatrique)
Pr Ait Sab · El Fakiri · Barrahouat · El Qadiri · El Baz · Lahmini · Rada · Maoulainaine · Slitine · Oulad Saiad · Fouraiji · Kamili · Aghoutane · El Fezzazi · Salama — FMPM

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 700 QEs (14 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Occlusion néonatale	35 Q	Pr Oulad Saiad
2	Infections respiratoires aiguës (pneumonie, bronchiolite)	30 Q	Pr El Fakiri
3	Infections neuroméningées de l'enfant (méningites)	30 Q	Pr Rada
4	Réanimation et soins immédiats du nouveau-né (+ EAI, asphyxie)	28 Q	Pr Maoulainaine
5	Fièvre de l'enfant (et convulsions fébriles)	28 Q	Pr Rada
6	Cyanose néonatale (test d'hyperoxie)	27 Q	Pr Slitine
7	Infections ostéo-articulaires de l'enfant	24 Q	Pr Aghoutane
8	Prématurité et ses complications	23 Q	Pr Slitine
9	Vomissements de l'enfant (et RGO)	22 Q	Pr Barrahouat
10	Pathologie du canal péritonéo-vaginal (hernie, hydrocèle)	19 Q	Pr Kamili
11	Particularités des fractures de l'enfant	18 Q	Pr Aghoutane
12	Asthme de l'enfant et du nourrisson	18 Q	Pr El Fakiri
13	Sténose hypertrophique du pylore	17 Q	Pr Kamili
14	Syndrome néphrotique (néphrose lipoïdique)	17 Q	Pr Ait Sab
15	Malformations congénitales (omphalocèle, laparoschisis, fentes)	17 Q	Pr Oulad Saiad
16	Retard staturo-pondéral (et hypothyroïdie)	16 Q	Pr El Qadiri
17	Alimentation et besoins nutritionnels	16 Q	Pr Barrahouat
18	Boiteries de l'enfant	15 Q	Pr El Fezzazi
19	Infections urinaires de l'enfant	15 Q	Pr Ait Sab
20	Dyspnée aiguë du nourrisson (laryngite, corps étranger)	14 Q	Pr Lahmini
21	Le diabète de l'enfant (et acidocétose)	14 Q	Pr El Qadiri
22	Déformations rachidiennes (scoliose)	11 Q	Pr El Fezzazi
23	Glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse	11 Q	Pr Ait Sab
24	Ictère néonatal (récurrent, non listé)	11 Q	Néonatalogie (récurrent)
25	Infection néonatale materno-fœtale (récurrent, non listé)	11 Q	Néonatalogie (récurrent)

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
26	Diarrhée aiguë et déshydratation (DHA)	11 Q	Pr Rada
27	Déficit immunitaire de l'enfant (récurrent, non listé)	11 Q	Pédiatrie (récurrent)
28	Tuberculose de l'enfant	10 Q	Pr Rada
29	Convulsions néonatales	10 Q	Pr Slitine
30	Syndrome hémorragique de l'enfant	10 Q	Pr El Baz
31	Anémies de l'enfant	10 Q	Pr El Baz
32	Pied du nouveau-né (pied bot)	9 Q	Pr Salama
33	Cardiopathies congénitales	9 Q	Pr Slitine
34	Arthralgies et arthrites de l'enfant	9 Q	Pr Ait Sab
35	Développement psychomoteur	9 Q	Pr Rada
36	Maladie luxante de la hanche	8 Q	Pr El Fezzazi
37	Masse abdomino-pelvienne (MAP)	8 Q	Pr Fouraiji
38	Purpura rhumatoïde	8 Q	Pr Ait Sab
39	Douleur abdominale de l'enfant	8 Q	Pr Kamili
40	Carences nutritionnelles (rachitisme, fer, kwashiorkor)	8 Q	Pr Barrahouat
41	Tumeurs osseuses malignes de l'enfant	7 Q	Pr Salama
42	Hernie diaphragmatique congénitale	7 Q	Pr Oulad Saiad
43	Diarrhée chronique de l'enfant (coeliaque, APLV)	7 Q	Pr Barrahouat
44	Cancers de l'enfant et leucémie aiguë	7 Q	Pr El Baz
45	Invagination intestinale aiguë	5 Q	Pr Oulad Saiad
46	Retard de croissance intra-utérin (RCIU)	5 Q	Pr Slitine
47	Atrésie de l'œsophage	5 Q	Pr Oulad Saiad
48	Hématuries	4 Q	Pr Ait Sab
49	Anomalie de migration testiculaire (cryptorchidie)	4 Q	Pr Kamili
50	Pleurésies de l'enfant	3 Q	Pr El Fakiri
51	Énurésie	3 Q	Pr Ait Sab
52	Insuffisance cardiaque du nourrisson	3 Q	Pr Slitine
53	Torsion du cordon spermatique	3 Q	Pr Fouraiji
54	Maladie de Hirschsprung	2 Q	Pr Oulad Saiad
55	Protéinurie chez l'enfant	2 Q	Pr Ait Sab
56	Coqueluche	1 Q	Pr El Fakiri
57	Uropathies de l'enfant	1 Q	Pr Oulad Saiad
58	Malformation ano-rectale (au programme, jamais tombé)	0 Q	Pr Oulad Saiad
59	Proctologie pédiatrique (au programme, jamais tombé)	0 Q	Pr Fouraiji

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Occlusion néonatale	35	2.50	5.0%
Infections respiratoires aiguës (pneumonie, bronchiolite)	30	2.14	4.3%
Infections neuroméningées de l'enfant (méningites)	30	2.14	4.3%
Réanimation et soins immédiats du nouveau-né (+ EAI, asphyxie)	28	2.00	4.0%
Fièvre de l'enfant (et convulsions fébriles)	28	2.00	4.0%
Cyanose néonatale (test d'hyperoxie)	27	1.93	3.9%
Infections ostéo-articulaires de l'enfant	24	1.71	3.4%
Prématurité et ses complications	23	1.64	3.3%
Vomissements de l'enfant (et RGO)	22	1.57	3.1%
Pathologie du canal péritonéo-vaginal (hernie, hydrocèle)	19	1.36	2.7%
Particularités des fractures de l'enfant	18	1.29	2.6%
Asthme de l'enfant et du nourrisson	18	1.29	2.6%
Sténose hypertrophique du pylore	17	1.21	2.4%
Syndrome néphrotique (néphrose lipoïdique)	17	1.21	2.4%
Malformations congénitales (omphalocèle, laparoschisis, fentes)	17	1.21	2.4%
Retard staturo-pondéral (et hypothyroïdie)	16	1.14	2.3%
Alimentation et besoins nutritionnels	16	1.14	2.3%
Boiteries de l'enfant	15	1.07	2.1%
Infections urinaires de l'enfant	15	1.07	2.1%
Dyspnée aiguë du nourrisson (laryngite, corps étranger)	14	1.00	2.0%
Le diabète de l'enfant (et acidocétose)	14	1.00	2.0%
Déformations rachidiennes (scoliose)	11	0.79	1.6%
Glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse	11	0.79	1.6%
Ictère néonatal (récurrent, non listé)	11	0.79	1.6%
Infection néonatale materno-fœtale (récurrent, non listé)	11	0.79	1.6%
Diarrhée aiguë et déshydratation (DHA)	11	0.79	1.6%
Déficit immunitaire de l'enfant (récurrent, non listé)	11	0.79	1.6%
Tuberculose de l'enfant	10	0.71	1.4%
Convulsions néonatales	10	0.71	1.4%
Syndrome hémorragique de l'enfant	10	0.71	1.4%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Anémies de l'enfant	10	0.71	1.4%
Pied du nouveau-né (pied bot)	9	0.64	1.3%
Cardiopathies congénitales	9	0.64	1.3%
Arthralgies et arthrites de l'enfant	9	0.64	1.3%
Développement psychomoteur	9	0.64	1.3%
Maladie luxante de la hanche	8	0.57	1.1%
Masse abdomino-pelvienne (MAP)	8	0.57	1.1%
Purpura rhumatoïde	8	0.57	1.1%
Douleur abdominale de l'enfant	8	0.57	1.1%
Carences nutritionnelles (rachitisme, fer, kwashiorkor)	8	0.57	1.1%
Tumeurs osseuses malignes de l'enfant	7	0.50	1.0%
Hernie diaphragmatique congénitale	7	0.50	1.0%
Diarrhée chronique de l'enfant (cœliaque, APLV)	7	0.50	1.0%
Cancers de l'enfant et leucémie aiguë	7	0.50	1.0%
Invagination intestinale aiguë	5	0.36	0.7%
Retard de croissance intra-utérin (RCIU)	5	0.36	0.7%
Atrésie de l'œsophage	5	0.36	0.7%
Hématuries	4	0.29	0.6%
Anomalie de migration testiculaire (cryptorchidie)	4	0.29	0.6%
Pleurésies de l'enfant	3	0.21	0.4%
Énurésie	3	0.21	0.4%
Insuffisance cardiaque du nourrisson	3	0.21	0.4%
Torsion du cordon spermatique	3	0.21	0.4%
Maladie de Hirschsprung	2	0.14	0.3%
Protéinurie chez l'enfant	2	0.14	0.3%
Coqueluche	1	0.07	0.1%
Uropathies de l'enfant	1	0.07	0.1%
Malformation ano-rectale (jamais tombé)	0	0.00	0%
Proctologie pédiatrique (jamais tombé)	0	0.00	0%
TOTAL leçons officielles (hors 3 récurrents non listés)	661 Q	47.21	94.4%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] OCCLUSION NÉONATALE

Pr Oulad Saïad • ~2.50 Q/examen

Le signe d'alarme cardinal : vomissements BILIEUX (verdâtres)

- Tout vomissement bilieux du nouveau-né/nourrisson = occlusion chirurgicale jusqu'à preuve du contraire → URGENCE
- Triade de l'occlusion néonatale basse : vomissements bilieux + distension abdominale + retard/absence d'émission méconiale
- À l'admission on cherche systématiquement : l'heure d'émission méconiale, on examine la marge anale (malformation ano-rectale), le périnée et les OGE, on vérifie la perméabilité de l'œsophage
- Δ *Ne JAMAIS rassurer ni renvoyer un nouveau-né qui vomit bilieux*

□ Concept le plus testé du module (≥10 sessions)

Volvulus sur mésentère commun = LA grande urgence (abdomen PLAT + bilieux)

- Nouveau-né/nourrisson normal jusque-là, vomissements bilieux brutaux avec abdomen PLAT (non distendu) → volvulus du mésentère commun
- C'est une urgence vitale (risque de nécrose intestinale) imposant le bloc
- Δ *Abdomen plat + bilieux ≠ atrésie : penser volvulus d'abord*

Orientation selon le niveau et l'âge

- Vomissements bilieux à H3 de vie + abdomen plat = atrésie duodénale (occlusion haute)
- Absence d'émission méconiale + distension = Hirschsprung / atrésie du grêle / iléus méconial (occlusion basse)
- Méconium normal : noir, émis dans les premières 24 h, abondant, indépendant de l'alimentation

Bilan : l'ASP debout est l'examen-clé

- Abdomen Sans Préparation (ASP) debout = examen de 1re intention (niveaux hydro-aériques)
- Bilan hydro-électrolytique (ionogramme) systématique avant le bloc
- Échographie abdominale utile (inversion des vaisseaux mésentériques dans le volvulus)
- Δ *La TDM et l'IRM ne sont PAS l'examen de 1re intention*
- Δ *Le lavement opaque/gastrographie n'est pas systématique en 1re intention dans l'occlusion néonatale*

[RANG 2] INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGÜES (PNEUMONIE & BRONCHIOLITE)

Pr El Fakiri • ~2.14 Q/examen

Pneumonie à pneumocoque : début BRUTAL, amoxicilline 100 mg/kg/j

- Début brutal, survient à TOUT âge, tableau pouvant être pseudo-chirurgical ou pseudo-méningé
- Traitement de 1re intention : AMOXICILLINE 100 mg/kg/j (et non amox-acide clavulanique)
- Peut se compliquer de pleurésie ; persistance de fièvre > 48 h → chercher une complication
- Δ *FAUX classiques : amox-clavulanique 50 mg/kg/j ; radio de contrôle « obligatoire » à J7 (NON systématique) ; complication par SHU (c'est faux, le SHU se voit avec E. coli/Shigelle)*

□ Tombe quasi chaque session (≥13)

Pneumonie à Mycoplasma pneumoniae : grand enfant, macrolides

- Touche l'enfant > 3-4 ans, début progressif
- Traitement = MACROLIDES (pas l'amoxicilline)

- Peut se compliquer d'hépatite, de Stevens-Johnson, d'une atteinte extra-pulmonaire
- **⚠ ⚠ Mycoplasme « fréquent avant 3 ans » = FAUX**

Bronchiolite virale aiguë (VRS) : PEC symptomatique pure

- VRS +++ : nécrose épithéliale + hypersécrétion muqueuse + œdème pariétal → rétrécissement endoluminal
- Débute par rhinopharyngite, puis distension thoracique + freinage expiratoire + sibilants/sous-crépitations bilatéraux
- PEC = désobstruction rhinopharyngée + hydratation correcte + fractionnement des repas. Antibiotique seulement si OMA associée
- **⚠ ⚠ PAS de kinésithérapie respiratoire systématique, PAS de corticoïdes, PAS de bronchodilatateurs systématiques, PAS d'antitussifs**

Critères d'hospitalisation de la bronchiolite

- Apnées, SaO₂ < 90-94 %, signes neurologiques/troubles de conscience, faciès toxique, sueurs
- Terrains : âge < 6 semaines, prématurité, cardiopathie congénitale, déficit immunitaire sous-jacent
- Refus alimentaire (< 50 % des rations)
- **⚠ ⚠ « âge < 6 mois » n'est PAS en soi un critère (le seuil retenu est 6 semaines) ; des sibilants bilatéraux isolés ne suffisent pas**

Indications de la radiographie thoracique dans les IRAB

- Asymétrie auscultatoire, doute diagnostique, persistance de la fièvre, pneumopathie récidivante, toux fébrile persistante
- Pneumonie à répétition → penser à un déficit immunitaire humoral
- **⚠ ⚠ La radio n'est PAS systématique devant toute suspicion de bronchiolite**

[RANG 3] INFECTIONS NEUROMÉNINGÉES (MÉNINGITES)

Pr Rada • ~2.14 Q/examen

Méningite du NOURRISSON : la raideur PEUT manquer

- La fièvre isolée peut être le seul symptôme révélateur ; signes : trouble du comportement, gémissement, fontanelle bombante, convulsion, torticolis
- Le pronostic dépend de la précocité de l'antibiothérapie → traitement démarré AVANT l'isolement du germe
- Complications : hydrocéphalie, surdité
- **⚠ ⚠ « La raideur de la nuque est indispensable/constante » = FAUX chez le nourrisson**
- **⚠ ⚠ « Traitement débuté après isolement du germe » = FAUX (on traite en urgence en probabiliste)**

□ Tombe à chaque session (14/14)

Profil du LCR selon le germe (LE tableau à mémoriser)

- Pneumocoque : installation RAPIDE, hypoglycorachie, PNN
- Haemophilus : installation INSIDIEUSE, hypoglycorachie
- Tuberculeuse : installation INSIDIEUSE, lymphocytaire, hypoglycorachie, paralysies des nerfs crâniens (ptosis), contagio tuberculeux
- Virale : lymphocytaire, normoglycorachie, contexte (oreillons → parotidite)
- **⚠ ⚠ Méningite TB « à début très aigu » ou « normoglycorachie » = FAUX (insidieuse + hypoglycorachie)**

Antibiothérapie & doses

- Bactérienne : CEFTRIAXONE 100 mg/kg/j (+ traitement de la fièvre, de la douleur, des convulsions)
- Méningite à méningocoque : ceftriaxone, en une seule prise/j ; chez l'enfant ≥ 45 kg on plafonne à la dose adulte
- Méningite tuberculeuse : schéma 2RHZE/10RH ; isoniazide max 300 mg/j
- **⚠ ⚠ Ceftriaxone « 50 mg/kg/j » pour une méningite = sous-dosé (FAUX)**

Prophylaxie de l'entourage (méningocoque) & déclaration

- Prophylaxie de l'entourage = RIFAMPICINE
- Maladie à déclaration obligatoire
- Devant un purpura fébrile (fulminant) : 1re conduite = ANTIBIOTIQUE immédiat (ceftriaxone) AVANT le transfert et avant la PL
- ⚠️ ⚠️ Devant un purpura fébrile, faire la PL ou l'hémoculture en premier = FAUX, on injecte l'antibiotique sans délai

[RANG 4] RÉANIMATION & SOINS IMMÉDIATS DU NOUVEAU-NÉ (EAI, ASPHYXIE)

Pr Maoulainaine • ~2.00 Q/examen

Évaluation à la naissance : 3 paramètres simplifiés

- Respiration + fréquence cardiaque + coloration = les 3 paramètres simplifiés de l'adaptation à la vie extra-utérine
- Anticiper la réanimation devant : RCIU, oligo/polyhydramnios, pré-éclampsie, césarienne en urgence, grossesses multiples, liquide méconial
- ⚠️ ⚠️ La réactivité à la sonde et le tonus ne font pas partie des 3 paramètres simplifiés

Clampage tardif du cordon

- Indiqué chez le nouveau-né à risque d'hypovolémie et chez le grand prématuré
- Technique : enfant placé ~20-30 cm sous l'introitus, clampage à 30-60 s

Encéphalopathie anoxo-ischémique (EAI) & hypothermie thérapeutique

- EAI = conséquence d'une asphyxie périnatale ; arguments : APGAR < 5 à la 5e/10e min, convulsions précoces, liquide méconial, anomalies du RCF (décélérations tardives, bradycardie), HRP/décollement placentaire
- 2 examens de 1re intention en cas d'asphyxie : EEG d'amplitude + gazométrie
- Hypothermie thérapeutique = améliore le pronostic neurologique (nouveau-né À TERME)
- ⚠️ ⚠️ Hypothermie thérapeutique CONTRE-INDIQUÉE chez le prématuré et chez l'hypotrophe

Classification de Sarnat & détresse respiratoire

- Sarnat & Sarnat évalue le statut neurologique : stade I hyperexcitabilité, stade II convulsions, stade III coma/hypotonie
- DR : tachypnée > 60 c/min ; pauses > 15-20 s ; CPAP nasale diminue le recours à l'intubation et améliore le pronostic de la MMH
- Inhalation méconiale : si nouveau-né NON vigoureux → intuber + aspirer puis ventiler ; si vigoureux → pas d'intubation
- ⚠️ ⚠️ Ne pas intuber/ventiler systématiquement en cas de liquide méconial si l'enfant est vigoureux

[RANG 5] FIÈVRE DE L'ENFANT (& CONVULSIONS FÉBRILES)

Pr Rada • ~2.00 Q/examen

Signes de gravité d'une fièvre du nourrisson (tolérance)

- Troubles de conscience/somnolence, teint gris, hypotonie, cri geignard, troubles hémodynamiques, détresse respiratoire, taches purpuriques
- CAT : authentifier la fièvre, évaluer la tolérance, déshabiller, examen clinique complet à la recherche de la cause
- ⚠️ ⚠️ « Fièvre > 39 °C » n'est PAS en soi un signe de gravité (c'est la tolérance qui compte)

Traitement symptomatique = MONOthérapie

- Traitement antipyrétique en MONOTHÉRAPIE + recherche de l'étiologie
- Causes les plus fréquentes au Maroc : OMA et infection urinaire
- ⚠️ *PAS de bithérapie, PAS d'alternance systématique de 2 antipyrétiques, PAS de bains répétés, PAS d'antibiothérapie systématique*

Nourrisson < 3 mois fébrile = prudence maximale

- Nourrisson de 2 mois fébrile sans foyer : NFS-CRP avant de décider + bandelette/ECBU + hémocultures
- Purpura fébrile : antibiotique en urgence (cf. méningite)

Crise convulsive fébrile : simple vs complexe

- Complexe si : durée > 15 min, signes focaux, déficit post-critique, âge < 1 an, récurrence dans les 24 h
- Après une CCF généralisée prolongée chez un nourrisson : 1er examen = PONCTION LOMBAIRE (éliminer une méningite)
- FdR de récurrence : âge précoce (< 15 mois), fièvre peu élevée, survenue précoce dans l'épisode fébrile

Éruptions fébriles classiques

- Varicelle : vésicules prurigineuses, érythème, transmission respiratoire, éviction scolaire, évolution en plusieurs poussées
- Rougeole : maculo-papuleux, signe de Koplik pathognomonique, catarrhe oculo-nasal
- Vésicules = varicelle + herpès (≠ scarlatine, rubéole, exanthème subit)
- Ecthyma gangrenosum (Pseudomonas) → ceftazidime + amikacine

[RANG 6] CYANOSE NÉONATALE (TEST D'HYPEROXIE)

Pr Slitine • ~1.93 Q/examen

Le test d'hyperoxie : O2 100 % pendant 10 minutes

- Définition : administration d'O2 à 100 % de FiO2 pendant 10 minutes
- But : différencier une cause CARDIAQUE d'une cause PULMONAIRE
- Cyanose qui RÉGRESSE (SaO2 s'améliore) → cause pulmonaire ; cyanose RÉFRACTAIRE (persistante) → cardiopathie cyanogène
- ⚠️ *FAUX : O2 à 50 % / 25 % / 21 %, ou 5 minutes — la seule bonne réponse est 100 % pendant 10 min*

□ Définition retombée presque chaque session (N2018, N2024, R2024, Nov2024, N2025, N2026...)

Confirmer la cyanose : SaO2 d'abord

- 1re étape devant un nouveau-né cyanosé = mesurer la SaO2 (puis test d'hyperoxie)
- L'anémie peut SOUS-ESTIMER la sévérité de la cyanose (moins d'Hb désaturée visible)

Cœur en COQUILLE D'ŒUF = Transposition des Gros Vaisseaux (TGV)

- Radio : médiastin étroit en « œuf couché » / coquille d'œuf = TGV (cardiopathie cyanogène par excellence du nouveau-né)
- Cyanose réfractaire au test d'hyperoxie → TGV, RVPA total, atrésie pulmonaire, sténose pulmonaire critique, atrésie tricuspide
- ⚠️ *Cœur en SABOT = Tétralogie de Fallot (à ne pas confondre avec la coquille d'œuf de la TGV)*

SaO2 différentielle (membre sup ≠ membre inf)

- SaO2 plus basse au membre INFÉRIEUR qu'au supérieur → obstacle gauche post-ductal (coarctation), éventuellement associée à une TGV
- Prise en charge d'une cardiopathie ducto-dépendante : PROSTAGLANDINES (prostine) pour maintenir le canal artériel + transfert + échocardiographie

[RANG 7] INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES DE L'ENFANT

Pr Aghoutane • ~1.71 Q/examen

Antibiothérapie probabiliste : amox-clavulanique 150 mg/kg/j ($\pm$ genta si sepsis)

- Ostéomyélite/arthritis SANS sepsis : amox-acide clavulanique 150 mg/kg/j seule
- AVEC signes de sepsis : amox-clavulanique 150 mg/kg/j + GENTAMICINE 5 mg/kg/j
- Forme grave/multifocale ou nouveau-né : trithérapie type céfalotine (C1G) + vancomycine + gentamicine
- ⚠️ ⚠️ *Posologies sous-dosées (80 mg/kg/j) ou amox seule = FAUX dans les formes documentées*

□ Antibiothérapie déclinée à de multiples sessions

Ostéomyélite aiguë hématogène

- Garçon ($\approx 2/1$), métaphyse des os longs (extrémité inférieure du fémur ++)
- Douleur métaphysaire brutale + fièvre/frissons, parfois notion de traumatisme
- Diagnostic précoce : la radio standard est souvent NORMALE au début ; hémocultures avant antibiotique
- ⚠️ ⚠️ « La notion de traumatisme est toujours retrouvée » et « porte d'entrée toujours en regard » = FAUX

Spondylodiscite : refus de marcher/de s'asseoir + psoïtis

- Signes : refus de marcher ou de s'asseoir, psoïtis, raideur/perte des courbures rachidiennes (rectitude), difficulté à ramasser un objet
- Radio standard du rachis souvent NORMALE au début ; scintigraphie = HYPERfixation
- ⚠️ ⚠️ « HYPOfixation à la scintigraphie » = FAUX (c'est une HYPERfixation) ; pas de syndrome méningé

Arthrite septique

- Hanche = localisation la plus fréquente chez le nouveau-né ; fièvre élevée souvent oscillante
- *Kingella kingae* = germe fréquemment incriminé chez le jeune enfant

[RANG 8] PRÉMATURITÉ & SES COMPLICATIONS

Pr Slitine • ~1.64 Q/examen

Score de FARR (et Ballard, Dubowitz) pour l'âge gestationnel

- Critères morphologiques du score de Farr : transparence/couleur de la peau, forme des oreilles, plis plantaires, OGE, lanugo, nodule mamelonnaire (tissu mammaire)
- Scores fiables d'AG : Farr, Ballard, Dubowitz (Ballard plus précis que Farr)
- ⚠️ ⚠️ *NE font PAS partie du score de Farr : plis palmaires, aspect des mains, forme des yeux*
- ⚠️ ⚠️ *Sarnat = neurologique, Thomson $\neq$ AG (pièges)*

Complications MÉTABOLIQUES du prématuré

- Hypoglycémie, hypocalcémie, hyponatrémie, hyperkaliémie, hypothermie
- ⚠️ ⚠️ *L'HYPOMAGNÉSÉMIE n'en fait PAS partie (FAUX récurrent) ; ni hypercalcémie, ni polyglobulie, ni hypernatrémie*

Complications RESPIRATOIRES : maladie des membranes hyalines (MMH)

- MMH (déficit en surfactant) + apnées + trouble de résorption du liquide pulmonaire
- MMH prévenue par la CORTICOTHÉRAPIE ANTÉNATALE ; peut survenir chez le nouveau-né de mère diabétique ; CPAP améliore le pronostic
- ⚠️ ⚠️ *MMH « chez le nouveau-né à terme exclusivement » = FAUX ; l'inhalation méconiale n'est pas une complication de la prématurité*

Entérocolite ulcéro-nécrosante (ECUN)

- Prématuré alimenté agressivement, distension abdominale + peau luisante + apnées $\rightarrow$ ECUN
- ASP : PNEUMATOSE intestinale, pneumatose PORTALE, pneumopéritoine (perforation), NHA, rectorragies

[RANG 9] VOMISSEMENTS DE L'ENFANT (& RGO)

Pr Barrahouat • ~1.57 Q/examen

Règle d'or : vomissements BILIEUX = urgence chirurgicale

- Vomissements verdâtres/bilieux → éliminer en PREMIER une urgence chirurgicale
- Causes digestives ET extra-digestives (infection urinaire, méningite à éliminer si fièvre) ; examen sur enfant entièrement nu
- Hématémèse/hémorragie digestive → fibroscopie digestive haute (FOGD)
- *⚠ ⚠ Les examens paracliniques ne sont PAS systématiques ; l'échographie abdominale n'est pas systématique*

Intervalle libre + vomissements en jet → sténose du pylore

- Un intervalle libre après la naissance puis vomissements faits de lait caillé évoque une sténose hypertrophique du pylore

RGO : clinique, MHD, pas d'exploration systématique

- RGO : vomissements/régurgitations post-prandiaux précoces, déclenchés par le changement de position
- Traitement = mesures hygiéno-diététiques ; IPP réservés aux formes compliquées (œsophagite)
- RGO atypique : pneumopathies à répétition, asthme, malaises/bradycardie du nourrisson
- *⚠ ⚠ FOGD et pH-métrie NON systématiques ; le diagnostic ne repose PAS « toujours » sur la pH-métrie*

Œsophagite peptique du nourrisson

- Suspectée devant pâleur, méléna, vomissements striés de sang
- CONFIRMÉE par la FOGD ; si APLV associée → hydrolysate de PLV

[RANG 10] PATHOLOGIE DU CANAL PÉRITONÉO-VAGINAL (HERNIE, HYDROCÈLE)

Pr Kamili • ~1.36 Q/examen

Hydrocèle : transillumination POSITIVE, abstention < 2 ans

- Grosse bourse INDOLORE, irréductible, transillumination POSITIVE, orifice inguinal profond libre, siège scrotal → hydrocèle (non communicante)
- CAT : ABSTENTION + surveillance, réévaluation vers 2 ans (résorption spontanée fréquente)
- *⚠ ⚠ PAS de ponction évacuatrice, PAS de chirurgie urgente, PAS de réduction par taxis pour une hydrocèle*

Hernie inguinale ÉTRANGLÉE = urgence chirurgicale

- Tuméfaction inguinale DOULOUREUSE inflammatoire + vomissements bilieux + arrêt du transit → hernie étranglée
- CAT = chirurgie en URGENCE (acheminer au bloc)
- *⚠ ⚠ Devant une hernie étranglée/compliquée : PAS de réduction par taxis, PAS d'antalgiques en ambulatoire, ne pas « programmer dans une semaine »*

Canal péritonéo-vaginal : spectre lésionnel

- CPV partiellement perméable → hydrocèle communicante ; complètement → hernie inguino-scrotale
- Hernie de l'ovaire (fille) : cure rapide ; bilatéralité → craindre une anomalie du développement sexuel

[RANG 11] PARTICULARITÉS DES FRACTURES DE L'ENFANT

Pr Aghoutane • ~1.29 Q/examen

Classification de SALTER-HARRIS (décollements épiphysaires)

- Type 1 : décollement épiphysaire PUR (trait dans le cartilage de croissance, sans fragment osseux)

- Type 2 : décollement + coin/bout MÉTAPHYSAIRE (le plus fréquent)
- Type 3 : trait ÉPIPHYSAIRE (articulaire) ; Type 4 : trait MÉTAPHYSO-ÉPIPHYSAIRE (à cheval)
- Type 5 : écrasement du cartilage (pronostic le plus sombre)
- **⚠ ⚠ Bien rattacher : « bout métaphysaire » → type 2 ; « décollement pur » → type 1 ; « métaphyso-épiphysaire » → type 4**

□ Type quasi systématique à chaque session

Fractures spécifiques de l'os immature

- Motte de beurre : fracture-tassement corticale SANS solution de continuité
- Bois vert : une corticale PLIÉE, l'autre ROMPUE/discontinue
- Fracture de Mac Farland = décollement-fracture de la malléole interne ; fracture du condyle latéral = fracture ARTICULAIRE du coude

Fracture du col fémoral (classification de DELBET)

- Type II (transcervicale) et III (basicervicale) fréquentes ; risque majeur de NÉCROSE de la tête fémorale (élevé, > 10 %)
- Complication tardive : coxa vara si mal traitée
- **⚠ ⚠ « Risque de nécrose < 5-10 % » dans ces fractures déplacées = FAUX (risque élevé)**

[RANG 12] ASTHME DE L'ENFANT & DU NOURRISSON

Pr El Fakiri • ~1.29 Q/examen

Asthme du nourrisson : ≥ 3 épisodes de dyspnée sifflante

- Définition : ≥ 3 épisodes de dyspnée sifflante ; arguments : intervalle libre normal, réversibilité sous β2-mimétiques, atopie/dermatite atopique, croissance normale
- 1^{re} maladie chronique de l'enfant ; physiopathologie = réponse TH2
- Radio thoracique de face = éliminer les diagnostics différentiels
- **⚠ ⚠ Stridor, retard staturo-pondéral, diarrhée chronique → orientent AILLEURS (faux pour l'asthme) ; physiopathologie « TH1 » = FAUX (c'est TH2)**

Diagnostic positif (EFR) et test de réversibilité

- Clinique + EFR ; réversibilité : VEMS qui augmente de ≥ 12 % (ou ≥ 200-400 mL) après bronchodilatateur
- Prick-test possible dès > 3 ans (positif si papule ≥ 3 mm vs témoin)
- **⚠ ⚠ Seuils erronés (VEMS/CVF < 90 %, papule > 10 mm) = pièges FAUX**

Évaluation de la sévérité d'une crise

- Crise SÉVÈRE : troubles de conscience, tirage, SaO₂ ≤ 92 %, difficulté à parler
- Index prédictif d'asthme (API) majeurs : asthme parental, dermatite atopique de l'enfant

Traitement

- Crise : β2-mimétiques de courte durée d'action (± corticoïdes selon sévérité)
- Traitement de FOND : corticothérapie inhalée (± β2 longue durée d'action en association fixe) ; objectif = CONTRÔLE + éducation thérapeutique + plan d'action

[RANG 13] STÉNOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

Pr Kamili • ~1.21 Q/examen

Le tableau type : vomissements lactés EN JET après intervalle libre

- Nourrisson ~3-6 semaines, intervalle libre puis vomissements LACTÉS (lait caillé) post-prandiaux, faciles, EN JET, enfant affamé
- Examen : déshydratation, abdomen PLAT, cassure pondérale

- Échographie abdominale = diagnostic (olive pylorique) ; ionogramme (alcalose métabolique hypochlorémique)
- *⚠ ⚠ Vomissements de la SHP NON bilieux (ne deviennent jamais bilieux) ; ils ne se tarissent PAS sous antiémétiques ; ils causent bien des troubles biologiques*

Diagnostic différentiel & traitement

- DD : RGO, APLV, atrésie/sténose duodénale, volvulus
- Traitement chirurgical = pylorotomie extra-muqueuse (Ramstedt) après correction hydro-électrolytique
- *⚠ ⚠ Ne pas traiter par antiémétiques en ambulatoire ni renvoyer à domicile*

[RANG 14] SYNDROME NÉPHROTIQUE (NÉPHROSE LIPOÏDIQUE)

Pr Ait Sab • ~1.21 Q/examen

Néphrose lipoprotéique = SN PUR, corticoSENSIBLE, de l'enfant 2-8 ans

- Cause la plus fréquente du SN de l'enfant ; lésions glomérulaires minimes (LGM)
- Syndrome néphrotique PUR (pas d'HTA, pas d'hématurie macro, fonction rénale normale), corticoSENSIBLE, RECHUTES fréquentes
- Œdèmes blancs, mous ; albuminémie < 30 g/L ; hypercholestérolémie ; complément NORMAL
- *⚠ ⚠ FAUX classiques : « complément bas », « HTA », « survenue avant 1 an », « un seul épisode », « mauvais pronostic rénal »*

Traitement de la 1re poussée

- PREDNISONE 60 mg/m²/j puis dégression sur 4,5-5 mois + régime sans sel
- Bolus de méthylprednisolone si non-rémission après 1 mois de corticoïdes pleine dose ; immunosuppresseurs si cortico-dépendance/résistance
- PBR indiquée si corticoRÉSISTANCE
- *⚠ ⚠ PBR d'emblée systématique = FAUX dans la forme typique de l'enfant*

Pièges & complications

- Douleurs abdominales + fièvre chez un enfant néphrotique → PÉRITONITE (à pneumocoque) à évoquer en premier
- Devant un SN impur (HTA, hématurie) ou chez l'ado → chercher lupus, purpura rhumatoïde, GNA, néphropathie

[RANG 15] MALFORMATIONS CONGÉNITALES (OMPHALOCÈLE, LAPAROSCHISIS, FENTES)

Pr Oulad Saïad • ~1.21 Q/examen

Omphalocèle vs laparoschisis (gastroschisis) : LE différentiel

- OMPHALOCÈLE : tuméfaction CENTRÉE sur l'ombilic, RECOUVERTE d'une membrane translucide ; malformations associées FRÉQUENTES → échocardiographie + vérifier perméabilité œsophage + examiner périnée
- LAPAROSCHISIS/gastroschisis : défaut PARA-ombilical DROIT, SANS membrane (anses à nu), ombilic en place
- *⚠ ⚠ Ne pas inverser : membrane + centré = omphalocèle ; pas de membrane + para-ombilical droit = laparoschisis*

CAT commune en salle de naissance

- Lutter contre l'HYPOTHERMIE + l'HYPOGLYCÉMIE, voie veineuse + perfusion, sonde gastrique, vérifier la perméabilité de l'œsophage, examiner le périnée
- *⚠ ⚠ Pas de TDM, pas de ponction de la masse, pas d'alimentation*

Fente labio-palatine & cataracte congénitale

- Fente labio-palatine : diagnostic anténatal possible, FAIRE rechercher des malformations associées / une entité syndromique ; chirurgie programmée
- Cataracte congénitale : penser rubéole congénitale, syphilis congénitale, glaucome congénital

[RANG 16] RETARD STATURO-PONDÉRAL (& HYPOTHYROÏDIE)

Pr El Qadiri • ~1.14 Q/examen

Âge statural < âge pondéral → cause ENDOCRINIENNE

- Quand l'âge statural est inférieur à l'âge pondéral (enfant plutôt grassouillet et petit) → hypothyroïdie, hypercorticisme, déficit en hormone de croissance
- RSP harmonieux à -4 DS isolé depuis le bas âge → déficit en GH (ou syndrome de Turner chez la fille, hypothyroïdie)
- ⚠️ ⚠️ *Maladie cœliaque/Crohn donnent un retard où le POIDS chute avant la taille (âge pondéral < statural)*

Hypothyroïdie congénitale : ictère prolongé + TSH HAUTE

- À évoquer devant un ictère néonatal PROLONGÉ ; anémie normochrome normocytaire ; traitement = L-THYROXINE
- Retard mental ÉVITABLE si traitement PRÉCOCE (intérêt du dépistage néonatal)
- ⚠️ ⚠️ *« TSH basse » dans l'hypothyroïdie périphérique = FAUX (la TSH est ÉLEVÉE)*

[RANG 17] ALIMENTATION & BESOINS NUTRITIONNELS

Pr Barrahouat • ~1.14 Q/examen

Allaitement maternel : composition (à mémoriser)

- Riche en IgA, oligosaccharides (maturation immunitaire), lactose (glucide principal), acides gras essentiels ; colostrum riche en immunoglobulines
- Fer en quantité MINIME mais à BIODISPONIBILITÉ élevée ; pauvre en vitamine K ; protéines solubles > caséine ; dépourvu de β -lactoglobuline
- Indiqué notamment en cas d'APLV ; teneur en lipides AUGMENTE au cours de la tétée
- ⚠️ ⚠️ *« Riche en vitamine K », « riche en fer (absorption élevée) », « majoritairement caséine », « dépourvu de protéines » = FAUX*

Règles de diversification

- Allaitement maternel EXCLUSIF jusqu'à 6 mois ; diversification (et gluten) à partir de 6 mois ; préparations pour nourrisson si allaitement impossible
- Nutriments énergétiques = protéines + glucides + lipides ($\neq$ vitamines/oligoéléments)
- ⚠️ ⚠️ *Lait de vache entier dès 6 mois = FAUX (déconseillé avant 1 an) ; farines dès 3 mois = FAUX*

Lait de vache entier vs lait maternel

- Lait de vache : plus de sodium, plus de caséine, plus d'AG saturés, moins d'AGPI ; fer à faible biodisponibilité

[RANG 18] BOITERIES DE L'ENFANT

Pr El Fezzazi • ~1.07 Q/examen

Approche par l'ÂGE (réflexe diagnostique)

- Grand enfant/ado ~13 ans (souvent en surpoids), boiterie douloureuse aiguë → ÉPIPHYSIOLYSE fémorale supérieure (stable ou instable)
- Enfant 4-9 ans, boiterie douloureuse chronique de hanche → ostéochondrite primitive de hanche (maladie de Legg-Perthes-Calvé)
- Spondylodiscite, séquelles d'arthrite/ostéomyélite, inégalité de longueur des MI = autres causes
- ⚠️ ⚠️ *Le psoriasis avec douleur de la FID oriente vers une cause abdominale (appendiculaire), pas vers une scoliose*

Boiterie douloureuse CHRONIQUE diaphysaire → tumeur

- Boiterie douloureuse depuis ~1 mois + douleur à la palpation DIAPHYSAIRE → tumeur maligne (sarcome d'Ewing)
- Boiterie aiguë fébrile avec impotence absolue → arthrite septique de hanche (urgence)

[RANG 19] INFECTIONS URINAIRES DE L'ENFANT

Pr Ait Sab • ~1.07 Q/examen

PNA du nourrisson : C3G IV + aminoside 2-4 j puis relais per os

- Pyélonéphrite du nourrisson : C3G injectable (céfotaxime) + aminoside 2-4 j, puis RELAIS per os (céfixime), durée totale 10-14 j
- PNA sans signe de gravité : C3G parentérale (± aminoside court) puis relais oral
- E. coli = germe n°1 (aussi Proteus, Klebsiella)
- ⚠️ ⚠️ *« C3G PARENTÉRALE pendant 10 jours » sans relais oral, ou « C3G ORALE d'emblée » pour une PNA = FAUX ; on ne traite pas une PNA « comme une méningite »*

Bilan morphologique systématique

- Échographie réno-vésicale systématique + évaluation de la fonction rénale ; chez le garçon → chercher des valves de l'urètre postérieur
- Cystographie rétrograde si anomalie échographique (RVU, etc.)

Spécificités nourrisson / nouveau-né

- PNA du nouveau-né : risque de sepsis important, peut se révéler par un ictère prolongé, localisations secondaires possibles
- Cystite (grand enfant/fille) : sans fièvre ; chercher oxyurose, troubles mictionnels ; éviter les antibiotiques injectables

[RANG 20] DYSPNÉE AIGUË DU NOURRISSON (LARYNGITE, CORPS ÉTRANGER)

Pr Lahmini • ~1.00 Q/examen

Type de dyspnée → niveau de l'obstacle

- INSPIRATOIRE (obstacle haut) : laryngite, corps étranger laryngé
- EXPIRATOIRE/sibilant : bronchiolite, asthme, corps étranger bronchique
- Dyspnée NON obstructive : pneumonie, insuffisance cardiaque, acidocétose diabétique

Corps étranger : la radio NORMALE n'élimine RIEN

- Syndrome de pénétration → bronchoscopie SYSTÉMATIQUE (diagnostique et thérapeutique)
- Une radiographie thoracique normale ne doit JAMAIS éliminer le diagnostic ; pneumonies récidivantes localisées → y penser ; risque : DDB si méconnu
- ⚠️ ⚠️ *« Radio normale → élimine le corps étranger » et « TDM systématique » = FAUX*

Laryngite virale du nourrisson

- Dyspnée INSPIRATOIRE ; diagnostic clinique ; traitement = CORTICOTHÉRAPIE ; chercher la possibilité d'un corps étranger
- Signes de gravité d'une dyspnée : troubles de conscience, tirage, FR > 60/min, tachycardie
- ⚠️ ⚠️ *Antibiothérapie systématique et radio systématique = FAUX dans la laryngite virale*

[RANG 21] LE DIABÈTE DE L'ENFANT (& ACIDOCÉTOSE)

Pr El Qadiri • ~1.00 Q/examen

Acidocétose diabétique (ACD) : réhydratation SSI 2 h + insuline IV

- Due à une insulino-pénie SÉVÈRE ; diagnostic = hyperglycémie + cétonurie + glycosurie ; peut simuler un abdomen chirurgical
- Réhydratation par sérum salé isotonique pendant 2 h (~10 mL/kg/h) + INSULINE RAPIDE par voie IV + recherche d'un facteur déclenchant + surveillance par dextro
- Complication redoutée : ŒDÈME CÉRÉBRAL (si réhydratation mal conduite)
- ⚠️ ⚠️ *Insuline par voie SOUS-CUTANÉE dans l'ACD = FAUX (IV) ; bicarbonates systématiques = FAUX ; remplissage « pendant 24 h » = FAUX (2 h)*

Diabète type 1 de l'enfant

- Forme la plus fréquente (insulinodépendant) ; l'insuline est le SEUL traitement ; peut révéler par énurésie secondaire + amaigrissement + polyphagie ; association possible à la maladie coeliaque
- Surveillance : microalbuminurie + FO (lampe à fente) après 3 ans ; TSH + anti-transglutaminases 1×/an ; échocœur après 5 ans
- ⚠️ ⚠️ *« Traité par régime seul » = FAUX*

Schémas d'insuline

- Insuline rapide avant les repas ; NPH (semi-lente) 2×/j ; analogues rapides avant/après repas
- Schéma à 2 injections : insuline rapide + intermédiaire, 2/3 matin – 1/3 soir, horaires rigoureux

[RANG 22] DÉFORMATIONS RACHIDIENNES (SCOLIOSE)

Pr El Fezzazi • ~0.79 Q/examen

La GIBBOSITÉ confirme la scoliose (rotation vertébrale)

- Gibbosité (au test de Adams) = signe qui CONFIRME ; rotation vertébrale sur la radio ; angle de COBB = tangentes aux vertèbres limites
- Dépistage : asymétrie des omoplates/épaules, hanche plus saillante, asymétrie distance bras-tronc, tête non centrée, coup de hache externe
- ⚠️ ⚠️ *Une déviation qui se CORRIGE après égalisation des MI = attitude scoliotique (FAUX positif), pas une vraie scoliose ; asymétrie des fossettes/épinos iliaques = inégalité des MI*

Signe d'alerte

- Rachis RAIDE et DOULOUREUX → évoquer en premier une origine TUMORALE (ou infectieuse)

[RANG 23] GLOMÉRULONÉPHRITE AIGÜE POST-INFECTIEUSE

Pr Ait Sab • ~0.79 Q/examen

Syndrome néphritique : hématurie + HTA + oligurie + œdèmes

- Hématurie MICROSCOPIQUE constante (macro inconstante, « urines bouillon sale ») + HTA + oligurie + œdèmes ; notion d'infection précessive

- Hypocomplémentémie TRANSITOIRE (C3 bas, se normalise < 8 semaines) ; souvent post-streptococcique mais aussi virale/parasitaire/fongique
- Évolution généralement bénigne ; forme extra-capillaire → insuffisance rénale ; traitement = restriction hydro-sodée ± diurétique
- **⚠ ⚠ La GNA ne RÉCIDIVE PAS ; hypocomplémentémie « persistante > 4 mois » = FAUX (penser à une autre néphropathie) ; pas d'immunosuppresseurs en règle ; ce n'est pas un SN « sévère »**

Diagnostics différentiels du syndrome œdémateux + HTA + hématurie

- Chez l'ado/fille : néphropathie lupique, néphropathie d'Alport (chercher une SURDITÉ familiale), purpura rhumatoïde
- Prévention : traitement correct d'une infection streptococcique

[RANG 24] ICTÈRE NÉONATAL (récurrent — non listé 25-26)

Néonatalogie (récurrent) • ~0.79 Q/examen

⚠ Statut : sujet TRÈS récurrent mais NON listé séparément au programme officiel 2025-26

- À confirmer avec le programme : probablement intégré aux cours de néonatalogie. Inclus ici car il tombe à presque chaque session.
- 1er examen devant tout ictère néonatal = dosage de la bilirubine TOTALE, libre et conjuguée
- **⚠ Vérifier auprès de la faculté si ce thème est au programme cette année**

□ Récurrent : 11 questions sur 9 sessions (2017–2025)

Ictère à bilirubine LIBRE (indirecte) = hémolytique/non conjugué

- Étiologies : incompatibilité Rhésus, incompatibilité ABO, déficit en G6PD, hypothyroïdie, résorption d'hématome (céphalhématome), maladie hémorragique
- Conditions majorant la neurotoxicité (ictère nucléaire) : déficit en G6PD, asphyxie périnatale, hypoalbuminémie (< 40 g/L), prématurité
- Prévention de l'incompatibilité Rh = immunoglobulines anti-D ; photothérapie selon bilirubine totale + AG + âge postnatal
- **⚠ ⚠ Un ictère apparaissant à J1 (< 24 h) n'est JAMAIS physiologique**

Ictère à bilirubine CONJUGUÉE = cholestase (URGENCE diagnostique)

- Atresie des voies biliaires : absence de vésicule à l'échographie, selles décolorées, γGT élevées → chirurgie précoce (Kasai)
- Autres : syndrome d'Alagille, déficit en α1-antitrypsine

[RANG 25] INFECTION NÉONATALE MATERNO-FŒTALE (récurrent — non listé 25-26)

Néonatalogie (récurrent) • ~0.79 Q/examen

⚠ Statut : sujet récurrent non titré séparément au programme officiel 2025-26

- Probablement intégré aux cours de néonatalogie ; à confirmer avec le programme.
- Germes de l'infection néonatale PRÉCOCE (< 3 j, transmission souvent par amniotite) : Streptocoque B + E. coli (± Klebsiella) ; TARDIVE : staph doré, Klebsiella, strep B

□ Récurrent : 11 questions sur 9 sessions (2017–2025)

Diagnostic & antibiothérapie

- Signe NFS le plus spécifique = hyperneutrophilie à PNN IMMATURES (myélémie)
- Antibiothérapie probabiliste précoce = C3G (céfotaxime) + GENTAMICINE
- PL si : hémocultures positives, choc septique, signes neurologiques
- Signes de gravité : choc, détresse respiratoire avant H4, jumeau infecté

- **⚠ ⚠** Chez le nouveau-né on utilise le CÉFOTAXIME, pas la CEFTRIAXONE (risque d'ictère/compétition bilirubine)

Embryofœtopathies à évoquer

- Lésions bulleuses/desquamation à la naissance → syphilis congénitale, herpès congénital

[RANG 26] DIARRHÉE AIGUË & DÉSHYDRATATION (DHA)

Pr Rada • ~0.79 Q/examen

PEC = RÉHYDRATATION + RENUTRITION (le trépied)

- Bases : réhydratation (SRO par voie orale à volonté) + renutrition (poursuite de l'allaitement, alimentation adaptée) + recherche de signes de DHA
- Prévention : vaccination (rotavirus), hygiène, eau potable, lavage des mains
- **⚠ ⚠** PAS d'antibiothérapie systématique, PAS d'antiseptiques intestinaux, PAS d'antisécrétoires, PAS de mise au repos de l'intestin, PAS de lait de régime systématique, PAS d'arrêt de l'allaitement

Signes de gravité & complications de la DHA

- Signes de gravité : âge < 3 mois, terrain fragilisé, troubles de conscience, signes de choc, contexte socio-culturel défavorable
- Complications de la DHA : convulsions, insuffisance rénale aiguë, choc hypovolémique
- **⚠ ⚠** « Fièvre > 39 °C » ou « âge < 12 mois » ne sont pas en soi des critères de gravité

[RANG 27] DÉFICIT IMMUNITAIRE DE L'ENFANT (récurrent — non listé 25-26)

Pédiatrie (récurrent) • ~0.79 Q/examen

⚠ Statut : sujet récurrent non titré séparément au programme officiel 2025-26

- À confirmer avec le programme. Inclus car il tombe régulièrement.
 - 1er examen devant une suspicion de déficit immunitaire = NFS (lymphopénie)
- Récurrent : 11 questions sur 11 sessions (2017–2025)

Signes d'ALERTE d'un déficit immunitaire

- Ecthyma gangrenosum, candidose œsophagienne, ≥ 3 pneumonies/an, décès dans la fratrie, lymphopénie (< 1500/mm³, < 3000 chez le nourrisson)
- Bilan VIH si : ecthyma gangrenosum, tuberculose de l'enfant, lymphome de Burkitt
- DICS du nourrisson : reconnu sur la NFS (lymphopénie profonde)
- **⚠ ⚠** « 2 otites » ou « 1 pneumonie » sur un an ne suffisent PAS à évoquer un déficit immunitaire (pièges récurrents)

[RANG 28] TUBERCULOSE DE L'ENFANT

Pr Rada • ~0.71 Q/examen

Particularités : pauci-bacillaire, contaminateur FAMILIAL

- TB de l'enfant = PAUCI-bacillaire, contaminateur souvent intra-familial, formes ganglionnaires et extra-pulmonaires fréquentes
- Forme la plus fréquente = PRIMO-INFECTION (parfois latente, peut se compliquer d'atélectasie)
- Dépistage/enquête familiale = clé de la prévention
- **⚠ ⚠** « Rareté des formes ganglionnaires/extra-pulmonaires » et « fréquence de la résistance » = FAUX chez l'enfant

Diagnostic & traitement

- Confirmation = BACTÉRIOLOGIE (GeneXpert possible sur biopsie ganglionnaire) ; quantiféron explore l'immunité cellulaire
- Schéma : 2RHZE/4RH (forme commune) ; neuroméningée 2RHZE/10RH ; éthambutol si forme neuroméningée ou VIH
- ⚠️ Une IDR positive ne CONFIRME PAS la maladie (contact/BCG) ; le BCG ne protège pas à 100 %

[RANG 29] CONVULSIONS NÉONATALES

Pr Slitine • ~0.71 Q/examen

Convulsions SUBTILES = le type le plus fréquent

- Type le plus fréquent chez le nouveau-né = convulsions SUBTILES (mouvements oculaires, oro-bucco-linguaux, pédalage)
- Cerveau immature : myélinisation et synaptogenèse INCOMPLÈTES, systèmes excitateurs prédominant sur les inhibiteurs → convulsions restant localisées
- Plus fréquentes chez le PRÉMATURÉ ; cause n°1 = encéphalopathie anoxo-ischémique ; hypocalcémie/hypoglycémie ; PL utile
- ⚠️ « Convulsions tonico-cloniques généralisées les plus fréquentes » = FAUX (le cerveau immature ne les généralise pas) ; « myélinisation complète » = FAUX

[RANG 30] SYNDROME HÉMORRAGIQUE DE L'ENFANT

Pr El Baz • ~0.71 Q/examen

Hémophilie : TCA allongé, hémarthrose, hémostase primaire NORMALE

- Hémophilie (A : déficit facteur VIII ; B : facteur IX), liée à l'X : hémarthrose = manifestation la plus fréquente ; TCA (céphaline) ALLONGÉ ; hémostase primaire NORMALE
- Traitement = substitution en facteur déficitaire (VIII pour l'hémophilie A)
- ⚠️ « Hémostase primaire perturbée », « test de Coombs positif », « réserves en fer augmentées », « traitement par fer/fibrinolytiques » = FAUX

Maladie hémorragique du nouveau-né (MHNN) & PTI

- MHNN (carence en vitamine K) = la plus fréquente du nouveau-né ; prévention par vitamine K à la naissance (risque majoré si la mère prend certains médicaments)
- Purpura thrombopénique idiopathique (PTI) : purpura pétéchial diffus, thrombopénie, SANS splénomégalie/hépatomégalie, régression sous corticoïdes

[RANG 31] ANÉMIES DE L'ENFANT

Pr El Baz • ~0.71 Q/examen

Anémie microcytaire hypochrome : carence martiale vs thalassémie

- Carence en fer : microcytaire hypochrome, réserves en fer DIMINUÉES (ferritine basse)
- Thalassémie majeure : microcytaire hypochrome, mais résistance globulaire AUGMENTÉE, splénomégalie, diagnostic par électrophorèse de l'Hb
- ⚠️ « Diminution des réserves en fer » dans la thalassémie = FAUX (le fer est normal/augmenté)

Anémies hémolytiques

- Drépanocytose : crises douloureuses vaso-occlusives, diagnostic = électrophorèse de l'Hb, traitement = hydratation/antalgiques/transfusion-échanges

- Sphérocytose (Minkowski-Chauffard) : sphérocytes, ictère + splénomégalie ; déficit en G6PD : lié à l'X, déglobulisation déclenchée par les fèves/oxydants

[RANG 32] PIED DU NOUVEAU-NÉ (PIED BOT)

Pr Salama • ~0.64 Q/examen

Pied bot varus équien : la définition (4 composantes)

- Équin de la cheville/arrière-pied + VARUS de l'arrière-pied + ADDUCTION de l'avant-pied + SUPINATION de la plante
- Traitement = méthode de PONSETI (plâtres successifs) puis rééducation ; chirurgie en 2e intention
- ⚠ La « verticalisation du talus » (astragale vertical) caractérise le pied convexe, PAS le pied bot ; radio à la naissance INUTILE ; chirurgie d'emblée = FAUX

Malpositions (vs malformations) du pied

- Malpositions (ex. metatarsus, pied talus/calcanéus) = secondaires au modelage utérin, RÉDUCTIBLES, traitées par rééducation
- Toute anomalie du pied → RECHERCHER une luxation congénitale de hanche associée

[RANG 33] CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

Pr Slitine • ~0.64 Q/examen

Cyanogènes vs non cyanogènes

- Cyanogènes : tétralogie de Fallot, transposition des gros vaisseaux, atrésie pulmonaire/tricuspidie, hypoplasie du VG
- Non cyanogènes (shunt G-D) : CIA, CIV, persistance du canal artériel → complications : HTAP, RSP, troubles de ventilation
- ⚠ CIA/CIV/PCA ne sont PAS cyanogènes (shunt gauche-droite)

Coarctation de l'aorte & cardiopathie ducto-dépendante

- Coarctation : SaO2 membre inf < membre sup, abolition des pouls FÉMORAUX, tableau d'insuffisance cardiaque néonatale
- Hypoplasie du VG : insuffisance cardiaque « bleue », abolition des pouls fémoraux ET huméraux, atrésie mitrale associée → prostaglandines + transfert

[RANG 34] ARTHRALGIES & ARTHRITES DE L'ENFANT

Pr Ait Sab • ~0.64 Q/examen

Arthrite juvénile idiopathique (AJI) systémique = maladie de Still

- AJI systémique : fièvre oscillante évocatrice, éruption morbilliforme FUGACE, hépatosplénomégalie, syndrome inflammatoire ; risque de SYNDROME D'ACTIVATION MACROPHAGIQUE
- AJI oligoarticulaire : AAN + → risque OPHTALMIQUE (uvéite) → consultation ophtalmologique
- Facteur rhumatoïde positif → évolution plus sévère

Démarche devant des arthralgies

- Arthralgies aiguës fébriles + AEG → craindre une LEUCÉMIE, un RAA, un début d'AJI, une connectivite (lupus), un purpura rhumatoïde
- Gonalgie chronique isolée sans fièvre → bilan de tuberculose + AAN + écho ; éliminer une arthrite à pyogènes

[RANG 35] DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR

Pr Rada • ~0.64 Q/examen

Repères clés & tiré-assis

- Maintien de la tête acquis à 3 mois (exploré par le tiré-assis, conditionné par le tonus axial)
- Position assise : avec appui à 6 mois, sans appui à 9 mois
- ⚠️ « Maintien de la tête à 1 mois ou à 6 mois » = FAUX (c'est 3 mois) ; le maintien de la tête n'est pas exploré par le réflexe de parachute

Causes de retard psychomoteur

- Asphyxie périnatale, méningite néonatale, ictère nucléaire, hypothyroïdie, maladie métabolique, trisomie 21, prématurité
- Une RÉGRESSION psychomotrice évoque une maladie ÉVOLUTIVE
- ⚠️ « Tout retard impose un scanner » et « la cause est toujours centrale » = FAUX

[RANG 36] MALADIE LUXANTE DE LA HANCHE (LCH)

Pr El Fezzazi • ~0.57 Q/examen

Manœuvres d'Ortolani & Barlow chez le nouveau-né

- Ortolani (ressaut d'ENTRÉE/réduction) positif + Barlow négatif → hanche LUXÉE RÉDUCTIBLE → traitement par harnais de Pavlik SANS bilan paraclinique
- Signes de LCH : asymétrie des plis, limitation de l'abduction (< 60°), inégalité des MI, signe de Galeazzi/Kliscic, raccourcissement
- FdR : primiparité, sexe féminin, présentation du siège, torticolis, anomalie posturale (pied) associée
- ⚠️ Une ABDUCTION large (> 65-70°) n'est PAS en faveur d'une LCH ; deux FdR + examen normal ne suffisent pas à traiter (on surveille/échographie à 1 mois)

Hanche luxée irréductible & Galeazzi

- Limitation à 30° de l'abduction + raccourcissement sans ressaut → hanche luxée IRRÉDUCTIBLE → culotte d'abduction/Pavlik, radio du bassin vers 4 mois
- Galeazzi positif (boiterie indolore depuis la marche) → LCH ou inégalité des MI

[RANG 37] MASSE ABDOMINO-PELVIENNE (MAP)

Pr Fouraiji • ~0.57 Q/examen

Les 2 grandes tumeurs rétropéritonéales du flanc

- NÉPHROBLASTOME (tumeur de Wilms) : masse du flanc, ferme, sans franchir la ligne médiane
- NEUROBLASTOME (surrénalien) : masse pouvant franchir la ligne médiane, signes généraux, ecchymoses péri-orbitaires, syndrome de Pepper (métastases hépatiques)
- 1er bilan = échographie abdominale (puis NFS) ; varicocèle d'apparition récente → masse rétropéritonéale

Autres masses selon le siège

- Hépatoblastome : hépatomégalie ferme + α-fœtoprotéine ÉLEVÉE (tumeur maligne du foie, sur foie sain, avant 3-5 ans)
- Fille pubère + masse pelvienne à bord supérieur convexe + douleurs → hémato-colpos (imperforation hyménale) : examiner la vulve + toucher rectal

[RANG 38] PURPURA RHUMATOÏDE

Pr Ait Sab • ~0.57 Q/examen

Triade : purpura déclive + douleurs abdominales + arthralgies

- Purpura INFILTRÉ des membres inférieurs + douleurs abdominales + arthralgies, SANS fièvre ni AEG (vascularite à IgA)
- Dépister systématiquement l'atteinte RÉNALE (néphropathie à IgA)
- ⚠️ « Syndrome inflammatoire majeur », « tableau septique », purpura du visage = FAUX (le purpura est déclive)

Complications

- Digestives : invagination intestinale aiguë (rectorragies), nécrose/perforation intestinale, hémorragie digestive
- Rénales : hématurie, syndrome néphrotique ; orchite ; sténose urétérale
- ⚠️ La déformation articulaire n'est PAS une complication (arthralgies non destructrices)

[RANG 39] DOULEUR ABDOMINALE DE L'ENFANT

Pr Kamili • ~0.57 Q/examen

Signes de gravité & démarche

- Gravité : AEG, douleur permanente intense diurne ET nocturne, fièvre élevée + troubles de conscience, vomissements bilieux
- Échographie abdominale = examen paraclinique de 1re intention ; toucher rectal recommandé ; occlusion sur bride si cicatrice de laparotomie
- Hospitalisation si : doute diagnostique, suspicion de pathologie grave, douleur résistante aux antalgiques, instabilité hémodynamique

Piège néphrotique

- Enfant néphrotique + douleurs abdominales fébriles → PÉRITONITE (médicale, à pneumocoque) à évoquer en premier

[RANG 40] CARENCES NUTRITIONNELLES (RACHITISME, FER, KWASHIORKOR)

Pr Barrahouat • ~0.57 Q/examen

Rachitisme carentiel : vitamine D

- Survient chez le NOURRISSON ; déformations osseuses (genu varum), bourrelets épiphysaires, retard de dentition, hypotonie, retard de fermeture de la fontanelle
- Radio : incurvation en CUPULE de la métaphyse ; traitement = VITAMINE D
- ⚠️ « Ostéocondensation » radiologique, « carence en phosphore », « fermeture précoce de la fontanelle/craniosténose » = FAUX

Kwashiorkor & carence martiale

- Kwashiorkor = carence en PROTÉINES : œdèmes + anorexie ; traitement antiparasitaire systématique
- Carence en fer : mauvaise diversification, anémie MICROCYTAIRE, favorise les infections et les troubles du développement psychomoteur ; prévenue par l'allaitement maternel exclusif 6 mois
- ⚠️ Carence martiale « toujours sévère » ou « rare avant 2 ans » = FAUX ; anémie « macrocytaire » = FAUX

[RANG 41] TUMEURS OSSEUSES MALIGNES DE L'ENFANT

Pr Salama • ~0.50 Q/examen

Évoquer devant une douleur osseuse chronique

- Boiterie/douleur osseuse chronique (≥ 1 mois), douleur diaphysaire ou métaphysaire à la palpation, parfois nocturne → sarcome d'Ewing / ostéosarcome
- Arthralgies + AEG → éliminer une localisation hématologique (leucémie)
- ⚠️ ⚠️ *Ne pas rattacher une douleur osseuse persistante à un simple traumatisme : imagerie + avis spécialisé*

[RANG 42] HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

Pr Oulad Saiad • ~0.50 Q/examen

Détresse respiratoire + abdomen SCAPHOÏDE à la naissance

- Nouveau-né à terme, détresse respiratoire, abdomen SCAPHOÏDE (plat/creux), hémithorax (gauche) bombé, bruits HYDRO-AÉRIQUES intrathoraciques, déviation des bruits du cœur
- Diagnostic = radiographie THORACO-ABDOMINALE (face + profil) ; CAT : sonde gastrique, intubation/ventilation (PAS au masque), vérifier la perméabilité de l'œsophage
- ⚠️ ⚠️ *Ne PAS ventiler au masque (aggrave la distension digestive intrathoracique) ; ce n'est ni une MMH ni un pneumothorax à drainer*

[RANG 43] DIARRHÉE CHRONIQUE DE L'ENFANT (COËLIAQUE, APLV)

Pr Barrahouat • ~0.50 Q/examen

Maladie cœliaque : cassure pondérale + anti-transglutaminases

- Diarrhée chronique + ballonnement + cassure de la courbe staturo-pondérale ; anémie résistante au fer, hypocholestérolémie, ostéopénie
- Diagnostic = anticorps anti-TRANSGLUTAMINASE (IgA) + biopsie duodénale/jéjunale (atrophie villositaire) ; traitement = régime SANS GLUTEN à vie
- Une cassure pondérale avec diarrhée chronique évoque EN PREMIER la maladie cœliaque
- ⚠️ ⚠️ *Régime « riche/pauvre en protéines » ou corticothérapie pour la cœliaque = FAUX*

APLV & hydrolysats

- Nourrisson < 6 mois, diarrhée chronique → APLV à évoquer en premier ; traitement = hydrolysât poussé de PLV (riche en TCM, traces de lactose)
- Diarrhée chronique : pas d'antibiothérapie ; bilan étiologique si retentissement sur la croissance

[RANG 44] CANCERS DE L'ENFANT & LEUCÉMIE AIGUË

Pr El Baz • ~0.50 Q/examen

Leucémie aiguë : le MYÉLOGRAMME confirme

- Signes : pâleur, purpura/thrombopénie, fièvre prolongée, adénopathies, splénomégalie, douleurs articulaires ; hémogramme = pancytopénie ou hyperleucocytose + thrombopénie
- Diagnostic de CERTITUDE = MYÉLOGRAMME (blastes médullaires)
- ⚠️ ⚠️ *« La leucémie est toujours myéloblastique » = FAUX (LAL la plus fréquente chez l'enfant) ; anémie microcytaire isolée = FAUX*

[RANG 45] INVAGINATION INTESTINALE AIGUË

Pr Oulad Saïad • ~0.36 Q/examen

Nourrisson + pleurs paroxystiques + rectorragie

- Nourrisson ~6 mois, crises de pleurs PAROXYSTIQUES + vomissements + refus de biberon → invagination intestinale aiguë ; chercher les RECTORRAGIES (selles « gelée de groseille »)
- Échographie abdominale en urgence (boudin d'invagination, image en cocarde)

Traitement : réduction (lavement) ou chirurgie si compliquée

- Forme NON compliquée : désinvagination par lavement (air/hydrosolubles)
- Forme COMPLIQUÉE (syndrome occlusif) : réanimation + CHIRURGIE
- ⚠️ *Ne pas tenter une réduction par lavement en cas d'occlusion compliquée/perforation → bloc*

[RANG 46] RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRIN (RCIU)

Pr Slitine • ~0.36 Q/examen

RCIU dysharmonieux & complications

- RCIU dysharmonieux : aspect de « fœtus araignée », peau fine, panicule adipeux pauvre, enfant agité/affamé
- Complications à COURT terme : thrombopénie, hypoglycémie, hypothermie, polyglobulie ; à LONG terme : obésité, HTA, diabète (programmation fœtale)
- ⚠️ *« Hyperglycémie/hypercalcémie/hyperthermie » à court terme = FAUX*

Suivi de grossesse (rappel)

- Grossesse bien suivie : ≥ 3 consultations anténatales, glycémie à jeun, sérologies TORCH, ECU

[RANG 47] ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE

Pr Oulad Saïad • ~0.36 Q/examen

Hypersalivation + accès de suffocation à chaque tentative d'alimentation

- Nouveau-né, hypersalivation, accès de toux/suffocation/cyanose à chaque tentative alimentaire, parfois hydramnios anténatal et distension abdominale (fistule œso-trachéale inférieure)
- Diagnostic : test à la sonde (vérifier la perméabilité de l'œsophage = sonde butte) + radiographie THORACO-ABDOMINALE (sonde enroulée + aération digestive si fistule)
- ⚠️ *La FOGD n'est PAS l'examen de 1re intention ; transfert sonde d'aspiration en place, à jeun*

[RANG 48] HÉMATURIES

Pr Ait Sab • ~0.29 Q/examen

Hématurie macroscopique + HTA : éliminer une GNA

- Hématurie macroscopique + HTA : 1er examen = complément (C3) ; évaluer la fonction rénale
- Hématurie macroscopique avec CAILLOTS → origine urologique : hospitaliser + échographie réno-vésicale en urgence (≠ glomérulaire qui ne donne pas de caillots)
- ⚠️ *PBR en urgence/immédiate devant une hématurie = FAUX*

Hématurie récidivante

- Causes : maladie de Berger (néphropathie à IgA), lithiase urinaire, infection urinaire, GNA, uropathie malformative

- ⚠️⚠️ La néphrose lipoïdique ne donne PAS d'hématurie macroscopique

[RANG 49] ANOMALIE DE MIGRATION TESTICULAIRE (CRYPTORCHIDIE)

Pr Kamili • ~0.29 Q/examen

Définition & risques

- Cryptorchidie = arrêt de migration sur le trajet normal (testicule non descendu, non abaissable) ; risques : dégénérescence MALIGNNE et infertilité (surtout si bilatérale)
- Chirurgie (abaissement) recommandée vers 1 an ; chez le nouveau-né → réévaluer vers 1 an (descente spontanée possible)
- ⚠️⚠️ Testicule à la face interne de la cuisse/périnée = ECTOPIE (≠ cryptorchidie) ; testicule oscillant = descend puis remonte ; chirurgie « vers 4 ans » = trop tardif

[RANG 50] PLEURÉSIES DE L'ENFANT

Pr El Fakiri • ~0.21 Q/examen

Indications du DRAINAGE thoracique (pleurésie purulente)

- Pleurésies de l'enfant le plus souvent INFECTIEUSES ; PEC hospitalière
- Drainage si : détresse respiratoire importante, déviation médiastinale, mauvais contrôle du sepsis, épanchement dépassant la moitié de l'hémithorax
- ⚠️⚠️ Drainer un épanchement < 10 mm ou faire une kinésithérapie systématique = FAUX

[RANG 51] ÉNURÉSIE

Pr Ait Sab • ~0.21 Q/examen

Énurésie primaire MONOSYMPATOMATIQUE : isolée, nocturne

- Énurésie primaire monosymptomatique = isolée, nocturne, sommeil profond, sans fuites diurnes ni autres signes ; évolution souvent spontanément favorable
- Fuites diurnes + impériosité mictionnelle → vessie hyperactive/immature (hyperpressive), non monosymptomatique
- ⚠️⚠️ Fuites diurnes, encoprésie, troubles de la marche, infections urinaires à répétition, résidu post-mictionnel important → NON monosymptomatique (chercher une cause)

[RANG 52] INSUFFISANCE CARDIAQUE DU NOURRISSON

Pr Slitine • ~0.21 Q/examen

Triade : tachycardie + dyspnée/polypnée + hépatomégalie

- Triade clinique de l'IC du nourrisson : TACHYCARDIE + DYSPNÉE (polypnée) + HÉPATOMÉGALIE ; cardiomégalie (RCT > 0,6) à la radio
- ⚠️⚠️ HTA, bradypnée, cyanose ne font pas partie de la triade caractéristique ; les œdèmes périphériques sont rares chez le nourrisson

[RANG 53] TORSION DU CORDON SPERMATIQUE

Pr Fouraiji • ~0.21 Q/examen

Grosse bourse aiguë DOULOUREUSE = bloc en urgence

- Adolescent, grosse bourse aiguë DOULOUREUSE (douleur scrotale brutale, intense) → torsion du cordon : URGENCE → exploration chirurgicale immédiate au bloc
- L'échographie scrotale ne doit pas retarder la chirurgie
- ⚠️ *Demander une SCINTIGRAPHIE, des AINS en ambulatoire, ou « hospitaliser pour surveillance » = FAUX (perte de temps = perte du testicule)*

[RANG 54] MALADIE DE HIRSCHSPRUNG

Pr Oulad Saiad • ~0.14 Q/examen

Constipation + retard d'émission méconiale

- Devant une constipation du nourrisson : chercher un RETARD d'émission méconiale (> 24 h), un rectum VIDE au toucher rectal, les moyens utilisés pour évacuer
- Diagnostic = biopsie rectale (absence de cellules ganglionnaires) ; ≠ prolapsus rectal (masse anale rouge molle après la selle)

[RANG 55] PROTÉINURIE CHEZ L'ENFANT

Pr Ait Sab • ~0.14 Q/examen

Mécanismes & étiologies

- Mécanismes classiques : glomérulaire, tubulaire, hémodynamique (orthostatique), exsudation
- Protéinurie chez une fille → rechercher infection urinaire, GNA, lupus systémique, uropathie malformative
- ⚠️ *Le mécanisme de « SURCHARGE » (overflow, ex. myélome) n'est PAS un mécanisme classique chez l'enfant*

[RANG 56] COQUELUCHE

Pr El Fakiri • ~0.07 Q/examen

Bordetella pertussis : tropisme respiratoire, hyperlymphocytose

- Agent = Bordetella pertussis (BACTÉRIE) ; tropisme respiratoire et neurologique ; transmission maximale en phase CATARRHALE ; prévention = VACCINATION
- NFS : hyperleucocytose à prédominance LYMPHOCYTAIRE
- ⚠️ *« Agent viral » et « hyperleucocytose à PNN » = FAUX*

[RANG 57] UROPATHIES DE L'ENFANT

Pr Oulad Saiad • ~0.07 Q/examen

Bilan radiologique de 1re intention

- Devant une uropathie : échographie abdominale (1re intention) + uréthro-cystographie rétrograde (recherche d'un reflux/valves)
- Valves de l'urètre postérieur (garçon), reflux vésico-urétéral, syndrome de la jonction pyélo-urétérale, méga-urètre
- ⚠️ *L'UIV et la TDM ne sont pas les examens de 1re intention*

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0.9% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
HORS — Guillain-Barré / divers	6 Q	0.43

[HORS 1] SYNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ & DIVERS (questions inclassables)

6 questions historiques — hors leçons officielles 2025-26

Statut

- Ce bloc regroupe quelques questions ne correspondant à AUCune leçon officielle 2025-26 : surtout le syndrome de Guillain-Barré (polyradiculonévrite) et une question isolée d'hormonothérapie des cancers (probablement issue d'un autre module).
- À titre de culture générale uniquement.
- ⚠ Ne pas réviser en priorité — non au programme cette année

Syndrome de Guillain-Barré (rappel express)

- Polyradiculonévrite aiguë post-infectieuse : paralysie flasque ASCENDANTE, aréflexie, dissociation albumino-cytologique dans le LCR (protéinorachie élevée, cellularité normale)
- Surveiller la fonction respiratoire (risque de détresse) et la dysautonomie

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS PÉDIATRIE — MALADIES DE L'ENFANT

** SCORES & CLASSIFICATIONS À CONNAÎTRE **

Salter-Harris	I = décollement pur · II = + bout métaphysaire · III = épiphysaire · IV = métaphyso-épiphysaire · V = écrasement
Delbet (col fémoral)	II/III fréquentes — risque élevé de nécrose de la tête fémorale
Sarnat & Sarnat (EAI)	I hyperexcitabilité · II convulsions · III coma/hypotonie
Score de Farr / Ballard / Dubowitz	âge gestationnel (peau, oreilles, plis plantaires, OGE, lanugo, mamelon)
APGAR < 5 à 5-10 min	argument d'asphyxie périnatale / EAI
Angle de Cobb	scoliose — tangentes aux vertèbres limites
Test d'hyperoxie	O2 100 % × 10 min → cardiaque (réfractaire) vs pulmonaire (régressif)

** SEUILS, CHIFFRES & CRITÈRES CLÉS **

Marqueur / Critère	Indication
Amoxicilline (pneumonie à pneumocoque)	100 mg/kg/j
Ceftriaxone (méningite)	100 mg/kg/j
Amox-clavulanique (ostéo-articulaire)	150 mg/kg/j (± gentamicine 5 mg/kg/j si sepsis)
Prednisone (néphrose 1re poussée)	60 mg/m ² /j puis dégression sur 4,5-5 mois
ACD : réhydratation	sérum salé isotonique 2 h (~10 mL/kg/h) + insuline rapide IV
Albuminémie néphrotique	< 30 g/L (SN biologique)
Maintien de la tête	3 mois · assis avec appui 6 mois · sans appui 9 mois
Diversification / allaitement exclusif	6 mois (gluten dès 6 mois)
Lymphopénie (déficit immunitaire)	< 1500/mm ³ (< 3000 chez le nourrisson) · ≥ 3 pneumonies/an
Méningite TB / commune	2RHZE/10RH (TB neuroméningée) · 2RHZE/4RH (commune)

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (FAUX fréquents) **

- **⚠ Cœur en COQUILLE D'ŒUF** = TGV ; cœur en SABOT = Tétralogie de Fallot (ne pas confondre).
- **⚠ Hypothyroïdie congénitale** : la TSH est ÉLEVÉE (pas basse) ; évoquée devant un ictère prolongé.
- **⚠ Hypomagnésémie** n'est PAS une complication métabolique de la prématurité.
- **⚠ Vomissements de la sténose du pylore** : LACTÉS en jet, JAMAIS bilieux.
- **⚠ Néphrose lipoïdique** : complément NORMAL, pas d'HTA, corticosensible ; PBR seulement si corticorésistance.
- **⚠ GNA** : hypocomplémentémie TRANSITOIRE (< 8 sem), ne RÉCIDIVE PAS, hématurie microscopique constante.

- **⚠ Bronchiolite** : *ni kiné systématique, ni corticoïdes, ni bronchodilatateurs* ; seuil d'hospitalisation = 6 semaines (pas 6 mois).
- **⚠ Corps étranger bronchique** : *une radio NORMALE n'élimine jamais le diagnostic* → bronchoscopie.
- **⚠ Pied bot varus équin** : *PAS de verticalisation du talus (c'est le pied convexe)* ; radio inutile à la naissance.
- **⚠ Nouveau-né** : **CÉFOTAXIME** (pas ceftriaxone) ; purpura fébrile → antibiotique **AVANT** la PL.
- **⚠ Hémophilie** : hémostase primaire **NORMALE**, TCA allongé (≠ purpura/thrombopénie).
- **⚠ Pneumonie à pneumocoque** : amoxicilline 100 (pas amox-clav 50) ; mycoplasme = grand enfant + macrolides.

**** ARBRES DÉCISIONNELS & CAT EXPRESS ****

- Vomissements **BILIEUX** → occlusion chirurgicale jusqu'à preuve du contraire → ASP + ionogramme + bloc.
- Cyanose néonatale → SaO₂ → test d'hyperoxie (O₂ 100 % × 10 min) → réfractaire = cardiopathie → prostaglandines + écho.
- Purpura **FÉBRILE** → ceftriaxone immédiate **AVANT** transfert/PL.
- Grosse bourse aiguë **DOULOUREUSE** → torsion → bloc en urgence (pas de scintigraphie).
- Grosse bourse **INDOLORE** + transillumination + → hydrocèle → abstention/surveillance jusqu'à 2 ans.
- Hernie inguinale **ÉTRANGLÉE** (douleur + vomissements bilieux) → bloc en urgence (pas de taxis).
- PNA du nourrisson → C3G IV (+ aminoside) 2-4 j puis relais per os 10-14 j + échographie réno-vésicale.
- Diarrhée aiguë → SRO à volonté + renutrition (pas d'ATB/antiseptique/antisécrétoire systématiques).
- Boiterie : ado en surpoids = épiphysiolyse ; 4-9 ans = Legg-Perthes ; douleur diaphysaire chronique = tumeur ; aiguë fébrile = arthrite septique.
- Détresse respiratoire + abdomen scaphoïde + bruits hydro-aériques thoraciques → hernie diaphragmatique (NE PAS ventiler au masque).

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) — Version 1

Cross-match 700 QEs officielles × Cours AIO (pédiatrie + néonatalogie + chirurgie pédiatrique)

Pr Ait Sab · El Fakiri · Barrahouat · El Qadiri · El Baz · Lahmini · Rada · Maoulainaine · Slitine · Oulad Saiad · Fouraiji · Kamili · Aghoutane · El Fezzazi · Salama — FMPPM

Améliorations Version 1 :

- ✓ Banque taguée par spécialité re-cartographiée vers les leçons OFFICIELLES 2025-26 (58 leçons)
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → 57)
- ✓ Déduplication : chaque concept récurrent regroupé en une entrée unique
- ✓ FAUX explicites signalés par **⚠** (pièges du concours)
- ✓ 3 thèmes très récurrents mais non listés signalés (ictère néonatal, infection materno-fœtale, déficit immunitaire) — à confirmer avec le programme
- ✓ 2 leçons officielles sans aucune question signalées (malformation ano-rectale, proctologie)
- ✓ Aide-mémoire pédiatrique : scores, seuils, pièges, CAT express